

PHARMACODEPENDANCE ET MEDICAMENTS

DE L'USAGE A LA DEPENDANCE

Usage simple

- = Consommation sans complication, ponctuelle par curiosité ou par entraînement, occasionnelle en petite quantité

Mésusage

- = Utilisation intentionnelle non conforme d'un médicament

Abus

- = Consommation intentionnelle et excessive d'un ou plusieurs produits avec des conséquences préjudiciables à la santé

Pharmacodépendance (OMS) (= toxicomanie mais terme très stigmatisant)

- **Relation aliénante** à une substance psychoactive, dont l'absence de consommation entraîne une souffrance psychique, voire physique, caractérisée par **un état de manque**
- **Désir obsessionnel hautement prioritaire** de s'en procurer et d'en consommer de manière compulsive (craving), quelles que soient les conséquences pour sa santé

Dépendance psychique +/- physique

Dépendance psychique :

- Le **+ puissant** des facteurs de dépendance
- 2 mécanismes :
 - Etat de satisfaction dû **au plaisir** (renforcement positif)
 - **Soulagement d'un malaise** engendré par la privation du médicament (renforcement négatif)

Dépendance physique :

- Certains médicaments
- **Adaptation de l'organisme** à une consommation prolongée (**tolérance**)
 - **↑ des doses** pour retrouver l'effet initial
 - Risque **d'overdose** potentiellement létal.
- La privation du médicament entraîne un **syndrome de sevrage** (symptômes spécifiques de chaque produit)

Dépendance médicamenteuse

La dépendance médicamenteuse regroupe souvent 3 aspects différents :

- **Dépendance médicamenteuse méconnue**
 - Dérive d'une prescription médicale = escalade médicamenteuse
- **Dépendance médicamenteuse avérée :**
 - De nombreuses classes de médicaments peuvent aboutir à une addiction
 - Dépendance secondaire
- **Dépendance médicamenteuse des toxicomanes :**
 - Traitements de substitution aux opiacés (TSO), licites
 - Toxicomanie de trafic, illicite

TSO :

- **Prise en charge médicale**, qui inclut la prescription de médicaments : la méthadone ou la buprénorphine
- **Prise en charge psychologique et sociale** dont peuvent bénéficier les personnes dépendantes aux opiacés, héroïne ou morphine par exemple.

Comportements de transgression

La toxicomanie médicamenteuse peut aboutir à des comportements de transgression :

- Ordonnances volées, détournées ou falsifiées

Finalités :

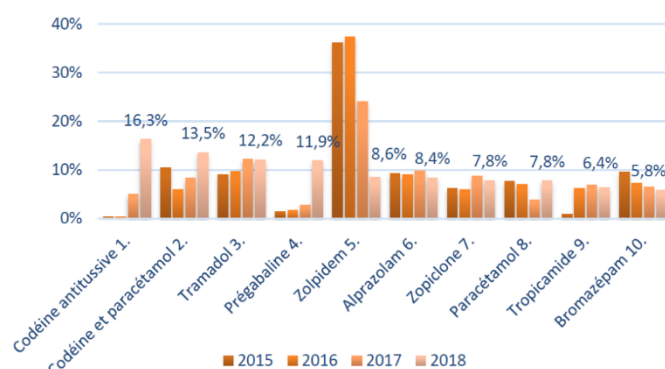
- Récréatives
 - Lucratives
 - Délictuelles
 - Criminelles
- ⇒ La soumission chimique en particulier, se définit comme **l'administration volontaire de substances psychoactives à l'insu d'une victime à des fins criminelles ou délictuelles** : viol, violence, vol, etc.

- **1950 ordonnances falsifiées** recueillies pendant 1 mois
- Les demandeurs étaient le + souvent des **hommes**
- L'âge moyen était de **35,7 ± 14,4 ans**
- Dans 9,7 % des cas, le patient était **connu de la pharmacie**

Critères de suspicion :

- Refuse de présenter sa carte vitale (29 %)
- Falsification évidente (fautes d'orthographe 8 %)
- Ordonnances connues comme volées

Evolution du **top 10** :



LES MEDICAMENTS PSYCHOTROPES NON OPIACÉS

Plusieurs catégories :

- **Anxiolytiques et hypnotiques** (benzodiazépines et apparentés +++)
 - Anxiolytiques = Entraîne rapidement une dépendance physique et une tolérance
 - Hypnotiques = peuvent diminuer la vigilance
- **Antidépresseurs**
 - Usage addictif rare
 - Exception : antidépresseurs anciens prescrits uniquement dans les dépressions résistantes
- **Antipsychotiques ou neuroleptiques :**
- **Régulateurs de l'humeur** (lithium notamment)
- **Psychostimulants** (méthylphénidate et modafinil)
- Dans la majorité des cas, la prise de ces médicaments ne relève **pas de pratiques addictives**, mais **thérapeutiques**
 - Parfois dans le cadre d'une automédication (surtout pour anxiolytiques/hypnotiques)
- Du fait des perturbations de la vigilance et des dépendances que certains entraînent, ces médicaments peuvent donner lieu à des **usages problématiques ou à risques**
 - Certains médicaments sont moins détournés que d'autres (antidépresseurs)
 - Certains médicaments sont très fréquemment mésusés (hypnotiques et anxiolytiques)
 - Le trihexyphénidyle (antiparkinsonien), le méthylphénidate et la Prégabaline sont parfois détournés dans des groupes d'usagers plus restreint

Des produits licites

- Les médicaments **psychotropes** sont obtenus sur **prescription**, même s'ils n'ont pas toujours été prescrits au consommateur lui-même
- **L'obtention par ordonnance falsifiée semble marginale**
 - 4 benzodiazépines ou apparentés figurent dans le top 10 des tentatives de falsification d'ordonnance
- Si le marché parallèle de médicaments peut être bien visible dans certaines zones des grandes villes, il s'agit **rarement d'un trafic organisé pour les psychotropes non opiacés**
- L'achat de médicaments sur internet semble **peu pratiqué**

Épidémiologie

Nombre de boîtes remboursées par habitant de > 20 ans en 2017 :

- **Anxiolytiques** : 1,4 (-6 % sur la période 2012-17)
- **Antidépresseurs** : 1,2 (~)
- **Hypnotiques** : 0,7 (-28 %)
- Un niveau de consommation de benzodiazépines **élevé** en France
- La France **ne se démarque pas** s'agissant des antipsychotiques ou des antidépresseurs
- L'utilisation des **psychostimulants est inférieure** à celle de nos voisins européens
- Peu de données quantitatives sur l'addiction aux médicaments psychotropes
 - Où se situe la frontière entre usage et mésusage ?

Un enjeu de santé publique !	
- En 2017, 21 % des > 15 ans ont été remboursés d'au moins 1 psychotrope - Une consommation plutôt ♀ (26 % contre 16 % chez les ♂), qui augmente avec l'âge - L'écart des sexes <u>s'amplifient avec le vieillissement</u>	
Une banalisation chez les jeunes	
- En 2017, chez les jeunes de 17 ans : 22 % déclarent avoir déjà utilisé un médicament psychotrope, les ♀ + souvent que les ♂ (30 % contre 14 %) Anxiolytiques (13 %), somnifères (10 %), antidépresseurs (5,2 %) et stimulants (1,6 %) - A 16 ans, 7 % des jeunes Français ont expérimenté la prise concomitante de médicaments et d'alcool « pour planer ou se défoncer » Les médicaments consommés n'ont pas toujours été prescrits à l'utilisateur : - Chez les 17 ans, la prise de médicaments psychotropes ne se fait à l'initiative d'un médecin que dans la moitié des cas environ - Dans 27 % des cas, c'est l'un des parents qui propose le médicament - Dans 11 % des cas, ils l'ont pris de leur propre initiative	
Risques liés à la consommation	
- Chez l'ensemble des consommateurs : troubles de la mémoire et du comportement, baisse de la vigilance, facilitant la survenue d'accidents - Principalement pour les <u>benzodiazépines</u> - Risques + importants en début de traitement, lors de prises occasionnelles, en association avec l'alcool ou d'autres psychotropes Des risques propres à chaque individu (en cas d'antécédents médicaux particuliers, de variations du métabolisme hépatique, de traitement au long cours ou à forte dose, d'associations médicamenteuses, etc.) Des mésusages de médicaments : abus, dépendance ou l'usage pour un autre effet que thérapeutique (usage « récréatif », dopage pour les psychostimulants, soumission chimique, etc.)	
Les usages non conformes	
Des durées de prescription non respectées - Anxiolytiques maximum 12 semaines, hypnotiques 4 semaines > pour 15 % des nouveaux utilisateurs de benzodiazépines - La durée médiane de traitement par une benzodiazépine est de 7 mois <u>Chez les usagers de drogues</u> - Principalement les benzodiazépines, obtenus sur prescription Rarement voie d'entrée dans la toxicomanie 36 % des usagers des centres d'accueil pour usagers de drogues (usagers actifs) déclarent en avoir pris au cours du dernier mois - Le mésusage est plus important chez les plus jeunes, les hommes, les plus précaires et les poly consommateurs Des pratiques d'injection sont parfois décrites mais VO+++ - Oxazépam, ↓ clonazépam (augmentation contraintes encadrant sa prescription), alprazolam, bromazépam - Des particularités régionales : méthylphénidate (Sud France), trihexyphénidyle (Réunion), prégabaline (les migrants), tropicamide Risque d'usage criminel - Benzodiazépines (Zolpidem et alprazolam) et soumission chimique	
Accidents de la route	
- En France, 3,4 % des accidents de circulation mortels sont liés à une prise de médicament - Les benzodiazépines sont responsables de la moitié des accidents mortels liés aux médicaments (risque ↑ 80 % et x8 en cas d'association avec l'alcool) - La prise de médicaments psychotropes donne lieu à des altérations de la vigilance et de l'état de conscience. Elle interdit donc la conduite - En cas d'accident grave des contrôles systématiques sont réalisés chez les conducteurs impliqués comme pour l'alcool et les stupéfiants	
 Soyez prudent Ne pas conduire sans avoir lu la notice  Soyez très prudent Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé  Attention, danger : ne pas conduire Pour la reprise de la conduite, demandez l'avis d'un médecin	

Un impact sanitaire et social mal estimé

- **Toute consommation de médicaments psychotropes n'est pas problématique MAIS**
 - Entre 2015 et 2017 : ↑ 35 % des demandes en addictologie
 - En 2015, les benzodiazépines sont citées comme 1er produit psychoactif ayant entraîné une dépendance dans 9 % des cas
 - En 2016, parmi les décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances, l'association de médicaments psychotropes est impliquée dans 1 décès sur 5

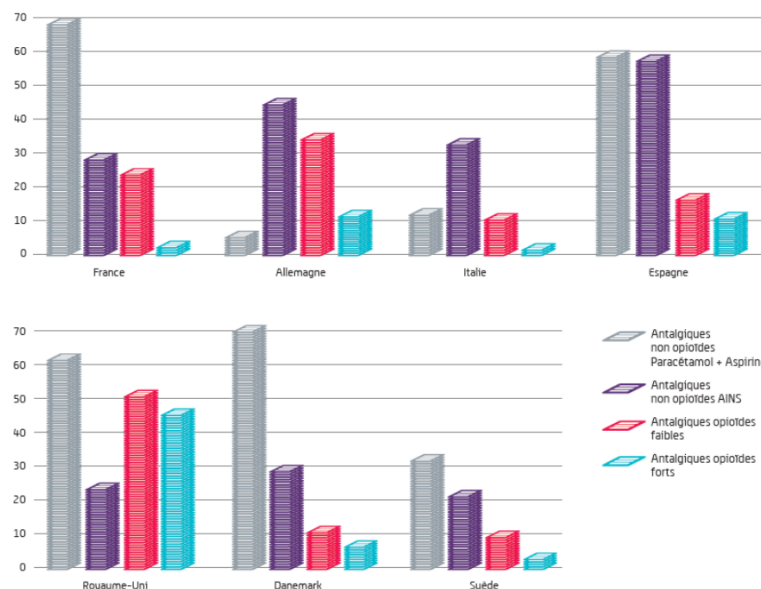
LES MEDICAMENTS PSYCHOTROPES OPIACES

- Une famille de produits obtenus à **partir de l'opium**, produit **sédatif** d'origine naturelle, provenant de **cultures de pavot**
 - **Alcaloïdes naturels** (opiacés) : morphine, codéine, papavérine, noscapine, buprénorphine
 - **Semi-synthétiques ou synthétiques** (opioïdes) : héroïne, hydromorphone, hydrocodone, oxycodone, oxycodone, méthadone, dihydrocodéine, tramadol, fentanyl
- Prescrits comme **antalgiques ou antitussifs, TSO** ou comme **anesthésiques**

Antalgiques opiacés

- Douleurs **modérées à sévères**
- Capacité ++ à induire une **dépendance psychique et physique**
- **Antalgiques de palier II (dits faibles)** : codéine, dihydrocodéine, tramadol, opium
 - Possible **détournement** d'usage
 - Risque de **dépendance** majoré en cas d'usage **prolongé** à **dose élevée**
 - Possible dépendance **physique**, surtout avec la codéine et le tramadol
- **Antalgiques de palier III** : morphine, fentanyl, oxycodone, hydromorphone
 - Lorsque les antalgiques - puissants sont **insuffisants**
 - Dans les douleurs **non cancéreuses** : utilisation **la + courte** possible !
 - Possible dépendance **psychique** et **physique rapide**

Épidémiologie



En Europe en 2015, la France se situe au **troisième rang** pour la consommation d'antalgiques opiacés faibles

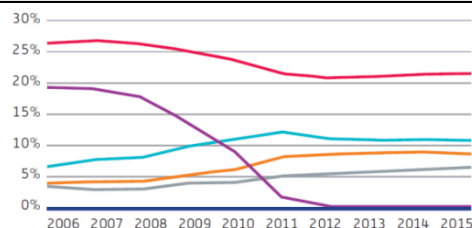
Le **tramadol** est la substance la plus utilisée dans **48 % des cas**.

En 2015 parmi les 7 pays analysés la consommation d'opiacés forts est **la plus basse en France**.

En France

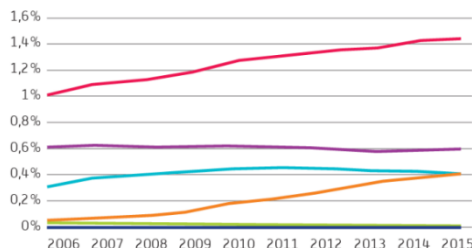
ÉVOLUTION DE LA PRÉVALENCE D'UTILISATION DES ANTALGIQUES FAIBLES, DE 2006 À 2015 DANS LA POPULATION DE L'ÉTUDE
(source : étude DANTE)

— Codéine/paracétamol — Opium/paracétamol
— Dextropropoxyphène/paracétamol — Tramadol
— Dihydrocodéine — Palier II



ÉVOLUTION DE LA PRÉVALENCE D'UTILISATION DES ANTALGIQUES FORTS, DE 2006 À 2015 DANS LA POPULATION DE L'ÉTUDE
(source : étude DANTE)

— Buprénorphine — Morphine
— Fentanyl — Oxycodone
— Hydromorphone — Total palier III



Le tramadol est l'antalgique opioïde le plus utilisé même si sa consommation globale seul ou en association tends à se stabiliser depuis 2013.

Le deuxième opioïde faible le plus consommé est la codéine en association avec le paracétamol qui marque la plus forte augmentation suivie par l'opium en association avec le paracétamol.

- ⇒ Au total **la consommation des antalgiques opioïdes faibles a diminué en 2011 puis s'est stabilisé.**
- ⇒ Au contraire le **recours aux antalgiques opiacés forts a nettement augmenté** dans notre pays au cours des 10 dernières années :
 - La morphine reste le plus consommé et l'Oxycodone marque la plus forte augmentation pour atteindre le même niveau que le fentanyl

En parallèle...

- Augmentation des hospitalisations pour surdosage d'antalgiques de **167 % entre 2004 et 2017**
- **↑ de 172 %** du nombre de décès par opioïdes depuis 2000
- **↑ de 88 %** depuis 2004 prescriptions pour des douleurs non cancéreuses

Intoxication par opiacés ou opioïdes

1. **Coma** (calme, hypotonique, avec myorelaxation)
 2. **Bradypnée** (fréquence respiratoire $\leq 12/\text{min}$)
 3. **Myosis** (bilatéral, serré, en tête d'épingle)
- Tous les morphiniques induisent une **dépression respiratoire** faisant courir le risque **d'apnée centrale et de décès**
 - L'association fréquente de **psychotropes**, tels que les benzodiazépines ou l'alcool, **↑ l'intensité de la dépression respiratoire**
 - La consommation par **voie injectable** expose à des **abcès** et à des **risques de contamination** (VIH, VHC, VHB)

Naloxone (Prenoxad®)

- Le nombre de **décès dus au surdosage de opiacés** est estimé à **400 par an** :
 - Concerne les usagers de substances illicites et les patients sous traitement morphinique
 - En cas d'overdoses opiacés un kit d'antidote est disponible en France : **PRENOXAD**

La Naloxone

- **Antagoniste pur et spécifique** des récepteurs opioïdes qui **bloque l'effet des opiacés par compétition**
- Prête à l'emploi par **voie injectable**
- **Ne dispense en aucun cas** d'une prise en charge médicalisée. Plusieurs risques existent :
 - **Moindre efficacité** de l'antidote suite à un surdosage en buprénorphine (action agoniste antagoniste).
 - Le risque de **réapparition des symptômes de surdosage** en cas d'overdoses avec la méthadone ($1/2$ vie longue)
 - Risque **d'apparition d'un syndrome de sevrage** chez les usagers chroniques par levée brutale des effets morphiniques : réveil avec confusion agressivité etc.

Antitussifs opiacés

- **« Purple drank »** = boisson à base de sirops antitussifs (prométhazine, codéine) et de soda
- 1ers signalements rapportés en France en 2013
- **Potentiel d'abus et de dépendance** :
 - Adolescents (♂ et ♀), jeunes adultes
- **Risques** : **troubles de la vigilance** (sommolence), du **comportement** (agitation, confusion, délire), **convulsions, décès**
- **En 2017** : 8,5 % des jeunes de 17 ans déclaraient avoir déjà consommé

Orientations publiques récentes

Les exonérations à la réglementation des substances vénéneuses relatives aux médicaments contenant les substances suivantes, telles qu'elles résultent de l'arrêté du 22 février 1990 modifié portant exonérations à la réglementation des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine, sont supprimées pour :

- **La codéine et ses sels**
- **L'éthylmorphine et ses sels**
- **Le dextrométhorphan et ses sels**
- **La noscapine et ses sels**

CQFR

- Parmi les médicaments psychotropes, les anxiolytiques et hypnotiques présentent un potentiel addictif reconnu
- Hypnotiques : PAS de prise régulière sur une longue période
- Anxiolytiques : dose minimale efficace pour limiter le risque de dépendance
- Le sevrage des psychotropes est toujours très progressif, sur plusieurs semaines et guidé par les symptômes
- DANGER en cas de prise concomitante d'alcool
- DANGER vis-à-vis de la conduite
- Les antalgiques ou antitussifs opiacés présentent un risque majeur d'abus ou de dépendance
- Antalgiques opiacés : réévaluation régulière et arrêt progressif
- Les antitussifs opiacés ne sont plus disponibles en vente libre depuis juillet 2017
- La dépendance aux opiacés peut nécessiter la mise en œuvre d'un TSO, des mesures d'accompagnement psychologique et de soutien à long terme pour prévenir une rechute
- L'intoxication ou « overdose » aux opiacés fait courir un risque de décès

ENFIN

- **D'autres médicaments peuvent faire l'objet d'abus et/ou de dépendance** : antihistaminiques sédatifs, antiparkinsoniens, antimigraineux, laxatifs et diurétiques (troubles du comportement alimentaire), corticoïdes et bronchodilatateurs (dopage), vasoconstricteurs, etc.
- Les signes d'alerte : **↑ des doses, nomadisme médical ou pharmaceutique, falsifications d'ordonnances, demande insistante pour un médicament et refus d'une alternative, prise du traitement des proches ou automédication...**

⇒ **Les médicaments en vente libre ne sont PAS sans danger !**